



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra



**¿Por qué el maní y los frutos
secos
ENTEROS son TAN peligrosos
antes de los 5 años?**

**Las infancias no deberían
consumir maní ni frutos
secos ENTEROS hasta los 5
años aproximadamente.**



La aspiración de un cuerpo extraño (CE) es un evento evitable que se observa, principalmente, en menores de 4 años.¹ En este grupo etario, la obstrucción de la vía aérea por un CE produce el 7% de las muertes.² No solo puede originar la muerte de manera inmediata, sino que, en ocasiones, es causa de lesiones cerebrales graves debidas a la hipoxia.³ También puede producir enfermedad respiratoria crónica (atelectasias, neumonías, bronquiectasias).

**¿Por qué? Porque no importa
"lo bien que mastiquen", su
masticación y deglución no
es igual a la de un adulto.**

Tampoco alcanza con estar a su lado, o "vigilarlos". No podemos preveer que estornuden, se rían, tengan hipo, se tropiecen o cualquier movimiento inesperado que lleve el trocito de fruto seco a la vía aérea.

Arch Argent Pediatr 2017;115(5):512-516 / 512

Recomendaciones sobre la prevención de la aspiración de cuerpos extraños orgánicos

Recommendations for the prevention of organic foreign bodies aspiration



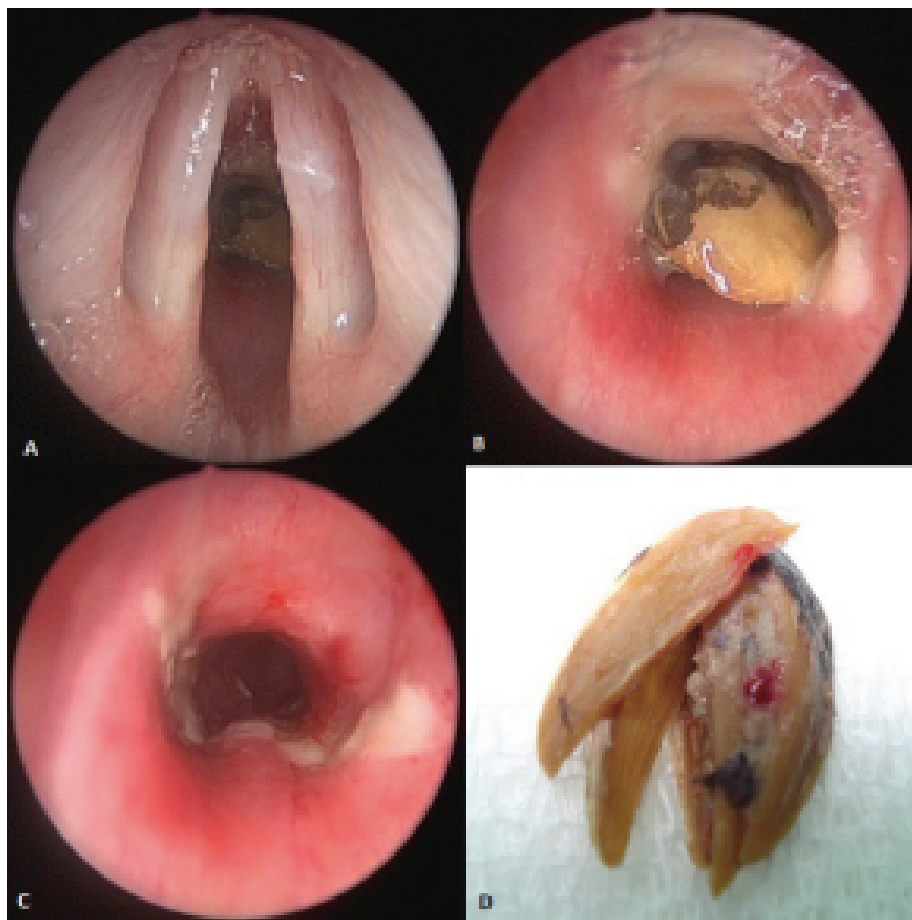
Sabrina Critzmann
Médica Pediatra



La mayoría de los episodios de asfixia ocurren bajo la supervisión de adultos, lo que sugiere que los padres y los cuidadores del niño no reconocen adecuadamente situaciones de riesgo y objetos peligrosos. Los pediatras son una fuente de información confiable y son fundamentales para promover la prevención de la aspiración de CE.⁸ La mayor conciencia pública a través de campañas en los medios de comunicación y la educación de los padres y cuidadores podrían reducir la incidencia de la morbilidad relacionada con la aspiración de un CE.

El problema con los frutos secos no es solo que "tapen" los cañitos por donde pasa el aire (con lo cual el oxígeno no podría llegar al cerebro y a los órganos).

FIGURA 3. Cuerpo extraño en tráquea (semilla de girasol)

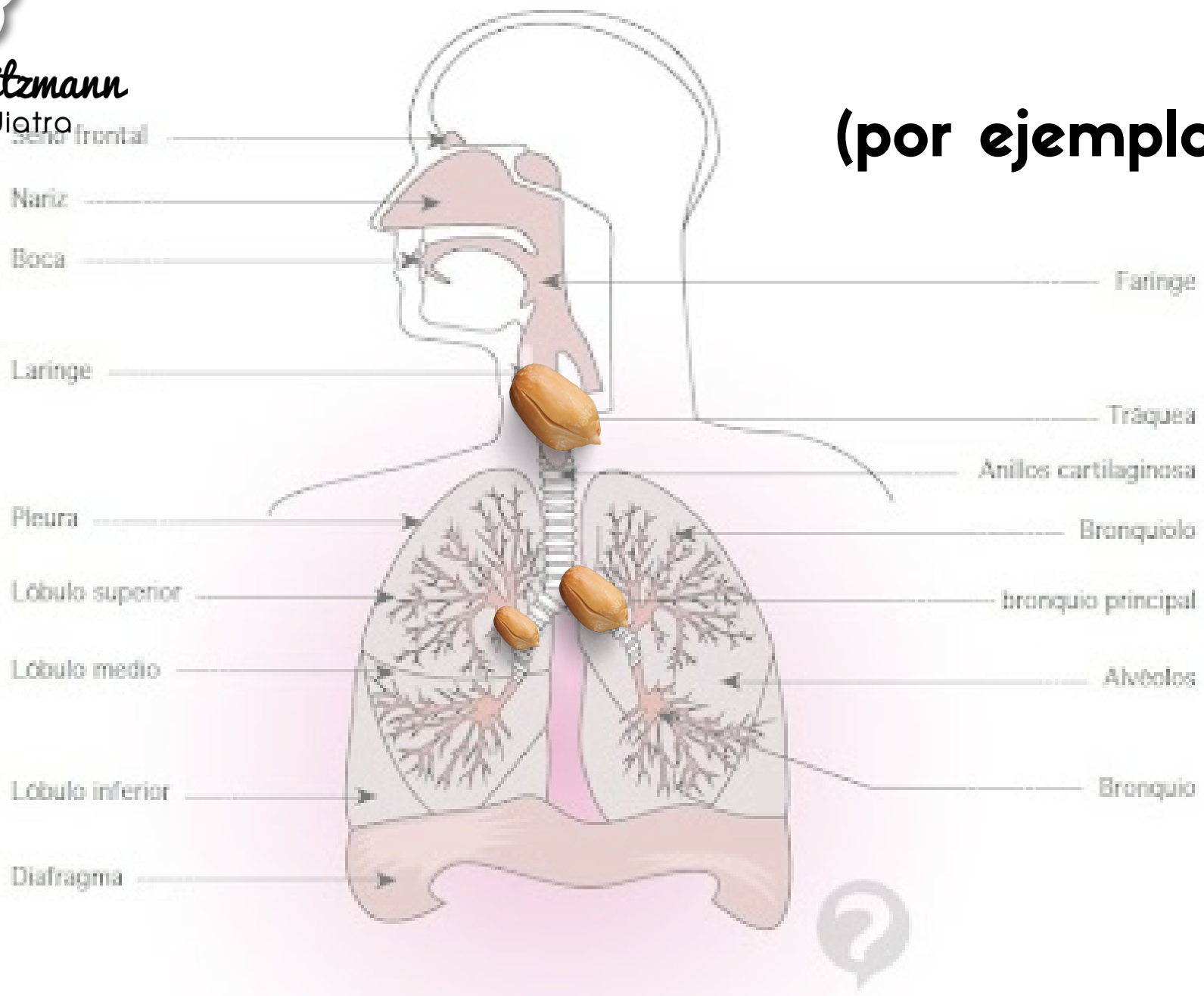


A y B. Imagen endoscópica. C. Imagen endoscópica post-extracción: edema y fibrina en tráquea. D. Semilla de girasol.

Es que, además, generan gran inflamación de estos cañitos, y eso complica más el cuadro.



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra



**El fruto seco o el trocito se puede
alojar en cualquier parte de lo que
llamamos "árbol bronquial",
generando irritación de los tejidos.**

EL cuerpo cuando reconoce un cuerpo extraño:



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra



Genera INFLAMACION y rechazo.

Los CE de origen vegetal ocasionan complicaciones más temprano que los inorgánicos. Por su contenido oleoso, generan una reacción inflamatoria importante en el árbol bronquial (neumonía lipoidea), que contribuye a la obstrucción temprana de la vía aérea, mientras que la identificación y la extracción endoscópica del objeto son más difíciles.¹⁶ Otros CE no se atascan y pueden generar granulomas (maní).⁹ Las semillas que se hidratan (maíz, poroto) se deben extraer lo antes posible, ya que, al absorber humedad, aumentan su tamaño y pueden obstruir la vía aérea.^{9,16}



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

Encima, los frutos secos desprenden aceites propios, y eso genera mayor irritación, inclusive llevando a lo que llamamos neumonía lipoidea.



Con lo cual, tal vez
tenemos la suerte de
que a través de
maniobras de
desobstrucción o de
una endoscopia se
pueda retirar
rápidamente el cuerpo
extraño PERO...

Figura 13. Rx de tórax de un varón de 22 meses diagnosticado de neumonía del LID



Figura 14. Rx de tórax realizada a los 2 meses de la de la Figura 13. Persistencia de la imagen inflamatoria en LID, aunque con mejoría parcial de la misma



Figura 15. Imagen endoscópica del caso de Figuras 13 y 14 en la que demuestra un cuerpo extraño en el bronquio intermediario derecho



Figura 16. Imagen del mismo cuerpo extraño (anacardo) de Figuras 13, 14 y 15 tras su extracción



Otras causas poco frecuentes de neumonía y/o atelectasia persistente son los **tumores endobronquiales**. En este caso la realización de la TC y la fibrobroncoscopia con toma de muestra, es fundamental para el diagnóstico (Figuras 17-20).

Figura 17. Rx de tórax de una niña de 10 años, con neumonía en el LID con componente de pérdida de volumen por atelectasia asociada, que no mejora a pesar de la antibioterapia adecuada. Mantoux 2 UT negativo



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra

..hay posibilidad de que el daño
pulmonar persista y que inclusive lleve
a complicaciones graves o la muerte.



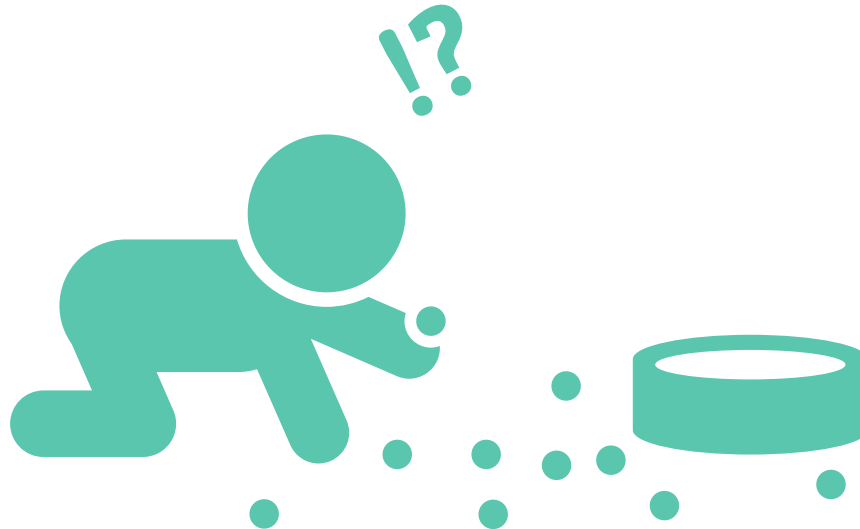
**Cremas o
harinas de frutos
secos**



**Si se puede prevenir, no es un accidente.
Seamos responsables, hay otras excelentes
formas de ofrecer frutos secos y maní desde
el inicio de la alimentación complementaria y
durante esos primeros años.**



Sabrina Critzmann
Médica Pediatra



Recordar además que las infancias son personas exploradoras y que más allá de los alimentos, saber las maniobras de desobstrucción es fundamental para el día a día.

Bibliografía de este post (de la cual también saqué las imágenes):

- Rodríguez H, Cuestas G, Gregori D, et al. Recomendaciones sobre la prevención de la aspiración de cuerpos extraños orgánicos. Arch Argent Pediatr 2017;115(5):512-516.
- Rodríguez H, Cuestas G, Botto H, Nieto M, Cocciaglia A, Passali D, Gregori D. Demora en el diagnóstico de un cuerpo extraño en la vía aérea en los niños: Serie de casos [Delayed diagnosis of foreign body in the airway in children: case series]. Arch Argent Pediatr. 2013 Jun;111(3):e69-73. Spanish. doi: 10.5546/aap.2013.e69. PMID: 23732358.
- Lobeiras Tuñón A. Ingesta-aspiración de cuerpo extraño. Protoc diagn ter pediatr. 2020;1:339-355.
- Andrés Martín A, Navarro Merino M, Pérez Pérez G. Neumonía persistente y neumonía recurrente. Protoc diagn ter pediatr. 2017;1:157-187.